

Evaluación del uréter bajo anestesia

Información para el paciente · Trazar un mapa de una estrechez del uréter antes de una reparación

WARWIKI

Este es un examen detallado del uréter — el tubo que lleva la orina del riñón a la vejiga — que se hace mientras usted está dormido bajo anestesia. Su cirujano combina varias pruebas para trazar con exactitud dónde está una estrechez y qué tan larga es, para poder planear la reparación correcta.

Acerca de esta prueba

Una estrechez (un **estrechamiento**) en el uréter es difícil de medir desde fuera, así que su cirujano la observa directamente mientras usted está dormido. Según lo que se necesite, el examen puede usar **cualquier combinación** de estas pruebas:

- **Ureteroscopia diagnóstica** — una cámara delgada y flexible que se sube por el uréter para mirar adentro.
- **Pielografía retrógrada** — se inyecta tinte *hacia arriba* por el uréter desde la vejiga, con radiografías, para delinear el conducto.
- **Pielografía anterógrada** — si usted tiene un tubo de drenaje del riñón, se hace pasar tinte *hacia abajo* desde arriba, a través de la estrechez.
- **Cistoscopia / cistograma** — una mirada dentro de la vejiga y radiografías de ella.

El objetivo es un mapa exacto — la ubicación, la longitud y qué tan apretada es la estrechez. Durante la misma visita se puede colocar o cambiar un **stent** o un tubo del riñón.

¿Es seguro?

Sí. Este es un examen común y de bajo riesgo. La mayoría de las personas solo tienen sangre en la orina por poco tiempo, ardor leve o un dolor en el costado después. Problemas poco frecuentes incluyen una infección de orina o una irritación pasajera del uréter; una pequeña lesión del uréter es rara. La anestesia por lo general es muy segura.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Uréter

El tubo que lleva la orina del riñón a la vejiga.

Estrechamiento (estrechez)

Un punto cicatrizado y estrecho que retarda o bloquea el flujo de orina.

Ureteroscopia

Mirar dentro del uréter con una cámara delgada y flexible.

Pielografía retrógrada

Radiografías del uréter y el riñón después de inyectar tinte hacia arriba desde la vejiga.

Pielografía anterógrada

Radiografías después de hacer pasar tinte hacia abajo desde un tubo de drenaje del riñón.

Sonda de nefrostomía

Un tubo que drena el riñón a través de la espalda; se puede dar tinte por él.

Medio de contraste (tinte)

Un líquido que se ve blanco en la radiografía para poder ver el conducto.

Stent

Un tubo interno blando que mantiene el uréter abierto; se puede colocar o cambiar.

¿LE DOLERÁ? Usted está dormido bajo anestesia, así que no siente nada durante el examen. Después, espere ardor leve al orinar, un dolor sordo en el costado, o orina con un poco de sangre durante uno o dos días. Es un procedimiento corto y por lo general regresa a casa el mismo día.

Cómo prepararse (antes de su prueba)

- Esto se hace bajo **anestesia** — siga todas las instrucciones de la cirugía (ayuno, y qué medicinas suspender, incluidos los anticoagulantes).
- Un **análisis de orina** verifica si hay infección — una infección activa debe tratarse primero.
- Deje colocado cualquier **tubo del riñón o stent** que ya tenga, y **organice quién lo lleve a casa**.

Avisé a su equipo con anticipación si usted:

- Alguna vez ha tenido una reacción al **medio de contraste de las radiografías o al yodo**
- Toma un **anticoagulante**, o tiene señales de una infección de orina

Qué sucede durante la prueba

- 1 Usted está dormido bajo anestesia y se le dan antibióticos.
- 2 Se pasa un cistoscopio a la vejiga. Se inyecta tinte hacia arriba por el uréter mientras se toman radiografías, y/o se sube una cámara por el uréter para mirar adentro.
- 3 Si usted tiene un tubo del riñón, se puede hacer pasar tinte hacia abajo desde arriba para mostrar la estrechez desde ambas direcciones.
- 4 Se traza el mapa de los hallazgos, y se coloca o se cambia un stent o un tubo del riñón si hace falta.

Después de la prueba

- Usted se recupera de la anestesia y por lo general **regresa a casa el mismo día** con alguien que lo lleve.
- Puede sentir **ardor leve, un dolor en el costado, u orina rosada** durante uno o dos días. Beber agua extra ayuda.
- Si se colocó un stent, es normal sentir algo de urgencia o molestia leve al orinar.
- Su cirujano revisa el mapa y conversa con usted los siguientes pasos de su reparación.

Llame al consultorio de su cirujano o busque atención si tiene:

- Fiebre o escalofríos
- Dolor en el costado o en el vientre fuerte o que empeora
- Sangrado abundante, o coágulos de sangre en la orina
- Dificultad para orinar, o náuseas o vómitos que no se pasan

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Este examen traza el mapa de una estrechez del uréter mientras usted está dormido, usando una cámara pequeña y tinte de radiografía desde abajo y/o desde arriba, para que su cirujano pueda planear la reparación correcta.
2. Como se usa anestesia, siga sus instrucciones de ayuno y de medicinas, trate primero cualquier infección, deje colocado cualquier tubo del riñón o stent, y organice quién lo lleve a casa.
3. La mayoría de las personas regresan a casa el mismo día. Es normal tener ardor leve, un dolor en el costado, o un poco de rosado en la orina durante uno o dos días — beba agua extra, y llame si tiene fiebre, dolor fuerte o sangrado abundante.